

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Capítulo1 2019 1 Online](#) / [Diabetes](#) / [Cuestionario Diabetes 1.1](#)

Comenzado el	domingo, 3 de marzo de 2019, 12:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 3 de marzo de 2019, 12:57
Tiempo empleado	17 minutos 1 segundos
Vencido	2 minutos 1 segundos
Puntos	0,00/15,00
Calificación	0,00 de 100,00

Pregunta **1**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 20 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de Lantus (insulina glargina) en la noche y tres dosis de insulina cristalina, previas al desayuno, almuerzo y cena, presenta la siguiente tabla de glicemias promedio:

	HGT peprandial	HGT postprandial
Desayuno	80	120
Almuerzo	90	170
Cena	100	190

Además su hemoglobina glicosilada es de 8%. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentar la dosis de Lantus
- ☐ b. Aumentar la insulina cristalina del desayuno y del almuerzo
- ☐ c. Aumentar la insulina cristalina del almuerzo y cena
- ☐ d. Aumentar la dosis de Lantus y de las 3 insulinas cristalinas
- ☐ e. Agregar una dosis matinal de Lantus

La glicemias preprandial dependen de la insulina lenta (glargina o NPH) recibida hace varias horas atrás (ej. la de ayuno depende de la NPH nocturna). En cambio, las glicemias postprandiales dependen de la insulina rápida (ultrarrápida o cristalina), aunque también dependen de la glicemia preprandial y de la comida misma.

En este caso, las glicemias postalmuerzo y postcena son las que están elevadas, por lo que se debe aumentar la insulina cristalina de esos horarios.

Recordar que el objetivo de glicemias es preprandiales menores a 100 mg/dl y postprandiales menores a 130 mg/dl, pero que lo más importante es la hemoglobina glicosilada menor a 7%.

La insulina lantus (glargina) se tendría que elevar si es que las glicemias precomidas estuvieran elevadas.

La respuesta correcta es: Aumentar la insulina cristalina del almuerzo y cena

Pregunta **2**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente diabético de 50 años, en tratamiento con dieta, se realiza una prueba de lípidos, que muestra Colesterol LDL de 120 mg/dl, TG: 600 mg/dl, HDL: 30 mg/dl. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Manejar con dieta
- ☐ b. Iniciar insulina
- ☐ c. Iniciar una estatina
- ☐ d. Iniciar un fibrato
- ☐ e. Iniciar ácido nicotínico

Por ser diabético, la meta de LDL es menor a 70, por lo que está elevada. Además tiene TG elevados (> 150) y HDL bajo (<40), por lo que el diagnóstico es una dislipidemia mixta. Si bien la regla general es que el LDL es la prioridad, en este caso tiene TG mayores a 500, por lo que la hipertrigliceridemia pasa a ser la prioridad y se debe tratar con fibrato.

Si los TG hubiesen sido menores a 500 (ej. 400), la respuesta habría sido la estatina.

La respuesta correcta es: Iniciar un fibrato

Pregunta **3**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 60 años se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 120 mg/dl. No ha presentado síntomas y su examen físico es normal. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Test de tolerancia a la glucosa
- ☐ b. Glicemia de ayuno
- ☐ c. Índice de HOMA
- ☐ d. Hemoglobina glicosilada
- ☐ e. Insulinemia basal

Recordar que si la glicemia es menor a 100 se considera normal y se da de alta; si está entre 100 y 125 se pide un TTGO y si está mayor a 125, se repite, para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus. En el embarazo, en cambio, las glicemias mayores o iguales a 100, se repiten.

La respuesta correcta es: Test de tolerancia a la glucosa

Pregunta **4**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Una paciente de 65 años, sin antecedentes mórbidos conocidos presenta un cuadro de palpitaciones, malestar y sudoración, luego de estar 5 horas sin comer. El cuadro se repite varias veces, siempre en relación al ayuno, por lo que decide hacerse un hemoglucotest, que demuestra una glicemia de 45 mg/dl durante uno de los episodios. ¿Qué examen es el más adecuado para determinar la etiología de la hipoglicemia?

Seleccione una:

- ☐ a. Glicemia de ayuno
- ☐ b. Test de tolerancia a la glucosa
- ☐ c. Niveles plasmáticos de insulina
- ☐ d. Niveles plasmáticos de glucagón
- ☐ e. Niveles plasmáticos de péptido C

Tiene hipoglicemias de ayuno (recordar que las causas son los insulinomas, el cáncer, la IRC y el DHC). Se estudia con péptido C (porque es más estable que la insulina). Si está alto es un insulinoma; si está bajo se buscan las otras causas.

En cambio las hipoglicemias reactivas (2 a 4 horas postprandiales) se estudian con el TTGO de larga duración.

La respuesta correcta es: Niveles plasmáticos de péptido C

Pregunta **5**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

¿Qué tratamiento está indicado ante la aparición de microalbuminuria persistente en un paciente con diabetes mellitus tipo 2?

Seleccione una:

- ☐ a. Insulina
- ☐ b. Dieta hipoproteica
- ☐ c. Dieta hiperproteica
- ☐ d. iECAs
- ☐ e. Atorvastatina

La microalbuminuria (mayor a 30 mg/día o RAC mayor a 0,03) persistente (mayor a 3 meses) es diagnóstica de nefropatía diabética inicial, que se maneja con IECA. La insulina sí está indicada en la nefropatía diabética, pero en la nefropatía establecida, con caída del clearance de creatinina y creatininemia mayor a 1,4.

La respuesta correcta es: iECAs

Pregunta **6**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 55 años, diabético tipo 2 en tratamiento con metformina 500 mg c/12 horas, presenta hemoglobina glicosilada de 8,5%, creatinina plasmática de 1,8 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 500 mg. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Agregar glibenclamida
- ☐ b. Aumentar la dosis de metformina
- ☐ c. Iniciar insulina
- ☐ d. Iniciar hemodiálisis
- ☐ e. Hacer énfasis en el seguimiento de la dieta y correcto uso de los hipoglicemiantes orales y controlar con

Por tener una IRC, con creatinina mayor a 1,4, están contraindicados los HGO y de elección es la insulina. En este caso, además tiene proteinuria, por lo que se debe iniciar un IECA. La HbA1c está en 8,5%, lo que muestra un mal control metabólico, pero per sé no indica la insulina. En cambio, si fuera mayor o igual a 9%, sería indicación de insulina. Al iniciar la insulina NPH se suele mantener la metformina y se puede mantener o suspender la glibenclamida, pero en este caso se debe suspender la metformina, por tener IRC.

La respuesta correcta es: Iniciar insulina

Pregunta **7**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 65 años, diabético tipo 2, de larga data, con tratamiento irregular con metformina y glibenclamida consulta por dolor intenso de la extremidad inferior izquierda, de tipo neurálgico, que recorre el dermatomo L4. Al examen físico se observa enflaquecido, con disminución de la sensibilidad distal y sin alteraciones motoras. La hemoglobina glicosilada resulta 9,9%. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Reforzar el tratamiento con hipoglicemiantes orales y controlar en 3 meses
- ☐ b. Suspender la glibenclamida y agregar insulina NPH nocturna
- ☐ c. Indicar zapatos adecuados y revisión diaria de los pies y regularizar el tratamiento con hipoglicemiantes orales
- ☐ d. Indicar un plan de ejercicios, reforzar la adhesión al tratamiento y controlar en 7 días
- ☐ e. Hospitalizar, iniciar insulino terapia y clomipramina oral

Tiene una neuropatía diabética dolorosa, por lo que se trata con ADTC (antidepresivos tricíclicos) e insulina. Además, por la HbA1c mayor a 9%, también está indicada la insulina. Probablemente se mantendrá la metformina.

La respuesta correcta es: Hospitalizar, iniciar insulino terapia y clomipramina oral

Pregunta **8**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente diabético tipo 2, acude a control ambulatorio. Actualmente está en tratamiento con metformina 850 mg cada 8 horas, aspirina 100 mg al día y enalapril 20 mg c/12 horas. En sus exámenes destaca creatinina 2,0 mg/dl, proteinuria 350 mg/dl, glicemia de ayuno: 140 mg/dl y HbA1c: 8,5%. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
- ☐ b. Aumentar la dosis de metformina
- ☐ c. Agregar glibenclamida al tratamiento
- ☐ d. Agregar rosiglitazona al tratamiento
- ☐ e. Iniciar insulina

Nuevamente, por la IRC (creatinina mayor a 1,4), están contraindicados los HGO e indicada la insulina.

La respuesta correcta es: Iniciar insulina

Pregunta **9**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 60 años, hipertenso, sufrió un infarto de pared anterior hace 1 año, el que fue manejado con angioplastia. Acude a control, con un perfil lipídico, con los siguientes valores: colesterol total: 220 mg/dl, colesterol HDL: 40 mg/dl, colesterol LDL: 160 mg/dl, triglicéridos: 100 mg/dl. Refiere no tomar ningún medicamento hipolipemiente ni seguir ninguna dieta. La conducta más adecuada para el manejo de sus lípidos es:

Seleccione una:

- ☐ a. Observar evolución
- ☐ b. Indicar dieta baja en grasas trans, grasas saturadas y colesterol y controlar en 3 meses
- ☐ c. Indicar dieta e iniciar una estatina
- ☐ d. Indicar dieta e iniciar un fibrato
- ☐ e. Indicar dieta e iniciar una estatina, asociada a un fibrato

Por tener un IAM previo, su riesgo cardiovascular es máximo y por tanto el objetivo de LDL es menor a 70 mg/dl. Además, tiene HDL bajo (menor a 40), pero TG normales (menores a 150). Por tanto, la prioridad será el manejo del LDL, lo que requiere una estatina, por tener riesgo cardiovascular máximo.

La respuesta correcta es: Indicar dieta e iniciar una estatina

Pregunta **10**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Una paciente ha presentado 5 hipoglicemias, las que han requerido hospitalización en varias oportunidades. Niega antecedentes de importancia, pero los familiares sospechan que está autoinduciéndose los síntomas. En la última hospitalización se realiza estudio que revela insulina de 55 UI/L y péptido C elevado. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

Seleccione una:

- ☐ a. Hipoglicemia facticia por insulina
- ☐ b. Hipoglicemia facticia por metformina
- ☐ c. Hipoglicemia facticia por glibenclamida
- ☐ d. Hipoglicemia facticia por pioglitazona
- ☐ e. Hipoglicemia de ayuno

Que el péptido C esté elevado significa que su páncreas está produciendo mucha insulina (la que está elevada también). La glibenclamida es una sulfonilúrea, por lo que aumenta la secreción de insulina (secretagogo), lo que es compatible con el cuadro.

La insulina exógena tendría insulina alta, pero péptido C bajo.

La metformina y la pioglitazona suelen no producir hipoglicemias, porque solo disminuyen la resistencia a la insulina. De todos modos, en caso de producirla, sería con insulina y péptido C bajos.

Las hipoglicemias de ayuno, también son con péptido C e insulina bajos.

La respuesta correcta es: Hipoglicemia facticia por glibenclamida

Pregunta **11**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un niño de 8 años presenta un cuadro de astenia y baja de peso, de cerca de 2 semanas de evolución. Además, presenta poliuria y polidipsia importante. Se solicita una glicemia de ayuno, que resulta 220 mg/dl. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Repetir la glicemia en 7 días
- ☐ b. Iniciar insulina NPH en dos dosis
- ☐ c. Iniciar insulina es esquema intensificado, con una dosis de insulina ultralenta (glargina) más refuerzos con insulina cristalina
- ☐ d. Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- ☐ e. Iniciar dieta, ejercicio y metformina

El diagnóstico es una diabetes mellitus, ya que cumple con el criterio de una glicemia mayor o igual a 200 (ya sea de ayuno o no), más síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, baja de peso). Por se un niño, se asume que la diabetes es tipo 1, es decir autoinmune y se inicia el tratamiento con insulina en esquema intensificado, que es el tratamiento de elección para este tipo de diabetes (y también para la diabetes LADA del adulto).

La respuesta correcta es: Iniciar insulina es esquema intensificado, con una dosis de insulina ultralenta (glargina) más refuerzos con insulina cristalina

Pregunta **12**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 56 años acude a control con el siguiente perfil lipídico: colesterol total: 348 mg/dl, colesterol HDL: 30 mg/dl, colesterol LDL: 190 mg/dl, triglicéridos: 640 mg/dl. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar dieta y ejercicio
- ☐ b. Iniciar dieta y una estatina
- ☐ c. Iniciar dieta y un fibrato
- ☐ d. Iniciar dieta y una asociación entre una estatina y un fibrato
- ☐ e. Hospitalizar e iniciar insulina cristalina

Tiene LDL elevado, TG elevados y HDL bajo. Por estar los TG sobre 500, pasan a ser la prioridad y se deben tratar con un fibrato.

Recordar que los médicos generales nunca deben mezclar fibratos con estatinas, ya que por un lado se dispara el riesgo de rabdomiólisis y por otro lado, todos los hipolipemiantes sirven en cierta medida para el tratamiento de las tres [dislipidemias](#).

La respuesta correcta es: Iniciar dieta y un fibrato

Pregunta **13**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente diabético, tipo 2, en tratamiento con metformina en dosis máxima, acude a control con los siguientes registros de glicemias promedio:

Predeayuno	90	Postdeayuno	140
Prealmuerzo	110	Postalmuerzo	170
Precena	115	Postcena	180

Además presenta una hemoglobina glicosilada de 7,5%. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Agregar glibenclamida y mantener la metformina
- ☐ b. Iniciar glibenclamida y suspender la metformina
- ☐ c. Iniciar insulina NPH matinal
- ☐ d. Iniciar insulina NPH nocturna
- ☐ e. Iniciar insulina cristalina junto con las 3 comidas

Su control metabólico es insuficiente, ya que la HbA1c está mayor a 7%. Además, salvo las glicemias de ayuno, todas las glicemias están elevadas. No tiene ninguna indicación de insulina, ni contraindicación de los hipoglicemiantes orales. Además, está solo con metformina en dosis máximas, por lo que es posible agregar glibenclamida, lo que es la respuesta correcta.

La respuesta correcta es: Agregar glibenclamida y mantener la metformina

Pregunta **14**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con dieta, el que sigue de manera irregular, consulta por dolor en ambas extremidades inferiores, que es de tipo urente y que es especialmente intenso en la noche. Al examen presenta alodinia, sin focalidad neurológica, ni lesiones en la piel. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar metformina y AINEs
- ☐ b. Iniciar glibenclamida y clomipramina
- ☐ c. Iniciar metformina y gabapentina
- ☐ d. Iniciar insulina y clomipramina
- ☐ e. Iniciar insulina y AINEs

Tiene una neuropatía diabética dolorosa, por lo que se trata con ADTC (antidepresivos tricíclicos, como la clomipramina, Imipramina y amitriptilina), más insulina. Recordemos que el diagnóstico de la neuropatía dolorosa es clínico (dolor neuropático, urente, con alodinia). La gabapentina y la pregabalina sí suelen usarse y son útiles, en particular en adultos mayores, en que están contraindicados los ADTC y cuando estos producen muchos efectos adversos. Sin embargo, los hipoglicemiantes orales no son suficientes y solo la insulina acelera la desaparición del dolor.

La respuesta correcta es: Iniciar insulina y clomipramina

Pregunta **15**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 500 mg cada 8 horas, acude a control. Trae una hemoglobina glicosilada de 10,3% y una proteinuria de 24 horas en 500 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el control metabólico de este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener la metformina y hacer hincapié en el cumplimiento de la dieta
- ☐ b. Aumentar la dosis de metformina a 850 mg cada 8 horas
- ☐ c. Agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas
- ☐ d. Agregar rosiglitazona
- ☐ e. Iniciar insulina

Tiene una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 9%, por lo que tiene indicación de iniciar con insulina NPH nocturna (10 UI por lo general, aunque hay distintos esquemas). La metformina se debe mantener, porque no hay insuficiencia renal o daño hepático que la contraindique y porque está demostrado que el control metabólico es mejor al mantener los hipoglicemiantes orales. Además, por la proteinuria, se asume que hay nefropatía, por lo que deberá iniciar un IECA (ejemplo enalapril).

La respuesta correcta es: Iniciar insulina

[◀ Resumen Diabetes](#)

Ir a...

[Cuestionario Diabetes 1.2 ▶](#)